Algoritmo CIF — Cervical

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Cervical. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. dd890e5d

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 3 si «SÍ»

3b ¿Rasgos neuropáticos, déficit de conducción o ninguno? Pueden coexistir; si el inicio fue traumático, el paso 2 ya añade el latigazo.

- **DOLOR RADICULAR →** 12 Dolor Radicular Cervical
- **RADICULOPATÍA →** 3 Radiculopatía Cervical
- **AMBOS →** 12 Dolor Radicular Cervical + 3 Radiculopatía Cervical
- **AURA MIGRAÑOSA →** sin hipótesis
- **FALLA LA MÉDULA →** 8 Mielopatía Espondilótica Cervical

→ sigue en el paso 4

SÍ

1 ¿Existen signos de compromiso medular (mielopatía)?

- **SÍ** — Alteración de marcha, hiperreflexia, signo de Hoffmann o Clonus positivos → 8 Mielopatía Espondilótica Cervical
- **NO** — Sin signos de mielopatía → sin hipótesis

todas →

2 ¿Hubo un mecanismo de aceleración-desaceleración reciente (latigazo cervical)?

- **SÍ** — ROM cervical significativamente reducido y síntomas de hiperalerta → 5 Trastornos Asociados a Latigazo Cervical (WAD)
- **NO** — Sin mecanismo traumático → sin hipótesis

todas →

3 ¿El dolor baja por el brazo y es peor que el del cuello?

- **SÍ** — Test de Spurling positivo, ULNT1 positivo o alivio con abducción del hombro → → desvío 3b
- **NO** — Sin irradiación predominante al brazo → sin hipótesis

NO → sigue en el paso 4, en la página siguiente →

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor cervical inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.

↓ Paso 4: viene del paso 3 o del 3b

4 ¿El síntoma principal es cefalea unilateral o dolor en base del cuello/hombro?

todas →

4b ¿Hay mareo o inestabilidad como queja principal o acompañante? Descartar antes lo vascular (5 D y 3 N, disección).

todas →

5 ¿Cuál es la función más alterada en este paciente?

Cefalea unilateral
Test de Flexión-Rotación Cervical <30° y síntomas C1-C2
→ 4 Cefalea Cervicogénica

Cefalea primaria
Criterios de migraña o tensional (el cuello puede contribuir)
→ sin hipótesis

Dolor en hombro/escápula
Restricción de movilidad de 1ª costilla
→ 10 Disfunción de 1ª Costilla (Articulación Costo-Vertebral Superior)

Dolor local/inespecífico
Sin cefalea ni irradiación dominante
→ sin hipótesis

MAREO CERVICOGÉNICO
Aturdimiento o inestabilidad ligados al cuello + error de reposición >4–5°
→ 13 Mareo Cervicogénico

VESTIBULAR
Vértigo rotatorio; tras golpe en cabeza o cuello, pensar también en conmoción
→ sin hipótesis

NO
Sin mareo
→ sin hipótesis

Déficit de Movilidad
ROM activo reducido y PAIVMs C0-C3 hipomóviles
→ 1 Disfunción Articular Cervical

Déficit de Coordinación
CCFT alterado o test de reposicionamiento alterado
→ 2 Disfunción Neuromuscular Cervical

Déficit de Fuerza
Reducción de fuerza de flexión o extensión cervical
→ 6 Debilidad Muscular Cérvico-Escapular

Déficit de Resistencia
Fatiga muscular en actividades funcionales
→ 11 Fatiga Muscular Cérvico-Escapular

Déficit Postural
Lordosis reducida o cabeza adelantada evidente
→ 9 Disfunción Postural Cérvico-Torácica

Dolor crónico inespecífico sin patrón dominante claro
→ 7 Dolor Mecánico Cervical Inespecífico Crónico

Todas → sigue en el paso 6 ↓

↓ Paso 6: viene del paso 5

6 ¿Dónde está la disfunción? En todos: tarea provocadora, postura, control motor y región torácica.

CRANEOCERVICAL (C1–2)
Dolor en los primeros grados de rotación, restricción precoz, FRT <30° o 10° de asimetría
→ 14 Dolor Cervical Idiopático

FACETA CERVICAL
Extensión-rotación positiva + disfunción segmentaria palpable y dolorosa
→ 14 Dolor Cervical Idiopático

CERVICAL BAJA Y CERVICOTORÁCICA
Giro libre al inicio pero excursión final limitada
→ 14 Dolor Cervical Idiopático

NINGUNO
No es idiopático o no se localiza
→ sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor cervical inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.